

Fecha Última Actualización: 14-08-2022 17:56:16

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Jonathan Andres Mandiola Campusano **Rut** : 17.707.509-4 **N° Archivo** : 1428513
Edad : 32a 5m 10d **Fecha Nacto**: 04/03/1990 **Sexo** : Masculino
Dirección : Rio Guadiana 2158 **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 5366 2731

N° Epicrisis
319230

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion **Fecha Ingreso** : 14/08/2022 13:22 **Días Estadía** : 1
Unidad de Egreso : Emergencia Adulto **Fecha Egreso** : 14/08/2022 17:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

A.Vigones

Hospitalización reciente(alta 29/07/22), dx de egreso:NAAS, Delirium mixto, Trombosis VCS relacionado a CVC, Miopatía del paciente crítico en rehabilitación

IRA resuelta:NAVM por ACBA MR (R Colistin, S Tige) + PSEA + KPN (R Colistin, S Tige), EPA resuelto. TQT decanulado 15/07 Bacteremia por SAMR HC 08/07 (-) tratada.

Crisis reactivas por neurolépticos

Antecedentes: ERC V, vejiga neurogénica, mala adherencia a CUP, paraparesia 2° a lesión medular L1 por bala, TBC tratada en 2017. TUS múltiples sustancias.

Alerg med: no

Ant qx:hernioplastia inguinal, cuerp ext pierna izq

Traido por disnea y compromiso de conciencia oscilante, Hipotenso, somnoliento, con venturi mucosas secas

ap resp: polipnea, crepitos

ap cv: rc ritmicos, frio distal, llene capilar < 4 seg

abdomen: rha+, blando, depresible, indoloro

tcsc: edemas++,

neurologico: somnoliento, despierta estimulo tactil, dice su nombre, orientado en espacio, desorientado en tiempo, obedece ordenes simples Familiar en conocimiento de pronóstico y decision de no HD, informado por equipo de nefrologia. Se comenta condición actual, manejo proporcional, no IOT, no RCP , no HD, no invadir

Diagnóstico: Insuficiencia Renal Crónica

Evolucion

Paciente con falla renal terminal, ingresa con hiperkalemia. Sin indicacion de TRR, por atcd. Se realizo manejo medico. Familia al tanto de pronostico ominoso. En compañía de familiares

Evoluciona con bradicardia extrema. Se constata PCR a las 17:10. Se informa a familia

Fecha Epicrisis : 14/08/2022 17:56

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 14-08-2022 17:56:16

Página 2 de 2

Confecciono certificado de defuncion
PCR COVID a la espera de resultado

Dg:
- Hiperkalemia severa

Vigoines

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Renal Crónica - HiperK severa

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Alan Vigones Araneda
Médico Tratante (Staff)